



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PROGRAM KERJA
KOMITE MUTU**

RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

TAHUN 2026

Jl. Raya Surabaya - Malang No. KM 54, Sukorejo - Pasuruan

Telp. 0341 - 6745000

Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

LEMBAR PERSETUJUAN

Program Kerja Komite Mutu
Rumah Sakit Prima Husada
Tahun 2026

Program kerja Komite Mutu ini dibuat sebagai rencana kerja komite mutu selama tahun 2026. peningkatan mutu adalah program yang disusun secara objektif dan sistematis untuk membantu menilai mutu serta kepatuhan kinerja staff dalam memberikan asuhan pada pasien di setiap unit kerjanya.

Disusun oleh:

Komite Mutu RS. Prima Husada

Malang, 16 November 2025

Disetujui oleh:

Direktur PT. Disa Prima Medika



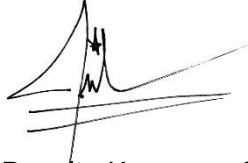
(dr. Sefrina Trisadi, Sp.DVE)

LEMBAR PENGESAHAN

Program Kerja Komite Mutu
Rumah Sakit Prima Husada
Tahun 2026

Disusun oleh:

Komite Mutu Rumah Sakit Prima Husada



(Lidia Puspita Kencana, S.K.M.)

Disetujui oleh:

Authorized Person



(Dr. dr. Aslichah, M.Kes., AFP., CHAE.)

Ditetapkan oleh:

Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo



(Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep., M.Kep.)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya Program Kerja Komite Mutu Rumah Sakit dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Program Kerja Komite Mutu Rumah Sakit disusun sebagai upaya untuk terselenggaranya kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan pasien secara menyeluruh yang sepenuhnya berorientasi pada standar mutu dan keselamatan pasien serta standar akreditasi.

Program ini akan dievaluasi kembali dan akan dilakukan perbaikan bila ditemukan hal-hal yang tidak sesuai lagi dengan kondisi Rumah Sakit. Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang dengan segala upaya telah berhasil menyusun program ini yang merupakan kerjasama dengan berbagai pihak.

Pasuruan, 16 November 2025

Penyusun

Komite Mutu Rumah Sakit

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN i

LEMBAR PENGESAHAN ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI iv

BAB I 1

PENDAHULUAN..... 1

 1.1 Latar Belakang..... 1

 1.2 Dasar Hukum..... 2

 1.3 Maksud dan Tujuan..... 3

 1.3.1 Maksud..... 3

 1.3.2 Tujuan 4

BAB II 1

GAMBARAN UMUM 1

2.1. Visi 1

2.2. Misi 1

2.3. Motto 1

2.4. 7 Nilai Budi Utama 1

2.5. SOTK Komite PMKP 1

BAB III 4

KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN..... 4

3.1. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan 4

3.2. Sasaran 6

3.3. Cara Melaksanakan Kegiatan..... 21

3.4. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2026 33

3.5. Kebutuhan Anggaran 48

BAB IV..... 48

MONITORING DAN EVALUASI 48

BAB V 49

PENCATATAN DAN PELAPORAN..... 49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) adalah suatu program institusional yang wajib dilaksanakan oleh rumah sakit secara terencana, terstruktur, dan berkelanjutan. Program ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta menjadi prasyarat esensial dalam pemenuhan Standar Akreditasi Nasional.

Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo telah berupaya melaksanakan peningkatan mutu dan keselamatan pasien sesuai standar yang ditetapkan. Namun, implementasi yang efektif memerlukan perencanaan tahunan yang detail untuk memastikan bahwa upaya peningkatan mutu tidak bersifat insidental, melainkan terintegrasi dalam seluruh sistem pelayanan. Seiring dengan semakin meningkatnya pendidikan dan latar belakang sosial ekonomi masyarakat, maka sistem nilai dan orientasi dalam masyarakat pun mulai berubah. Masyarakat mulai cenderung menuntut pelayanan umum yang lebih baik, lebih cepat, ramah, dan lebih bermutu, termasuk pelayanan kesehatan. Tuntutan ini menciptakan tantangan bagi Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo untuk tidak hanya memenuhi standar minimal yang diwajibkan, tetapi juga untuk melampauinya dan memberikan pengalaman pelayanan terbaik (*excellent service*). Untuk merespons tuntutan ini, PMKP harus menjadi strategi utama untuk menjaga kepercayaan publik dan meningkatkan daya saing institusi.

Meskipun Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo telah berkomitmen melaksanakan standar PMKP, hasil evaluasi Indikator Mutu Nasional (IMN) periode Januari hingga Oktober 2025 menunjukkan adanya kesenjangan kinerja (*performance gap*) signifikan di beberapa area krusial yang memerlukan intervensi programatis segera. Secara khusus, capaian di bawah target 80% dan 90% menunjukkan perlunya perbaikan mendalam pada sistem kepatuhan, yaitu Kebersihan Tangan dengan Tingkat kepatuhan berada di 79,16%, masih di bawah target dan berpotensi meningkatkan risiko Infeksi Terkait Pelayanan Kesehatan (HAIs). Waktu Tunggu Rawat Jalan dengan capaian hanya 71,23%, mengindikasikan rendahnya efisiensi alur pelayanan dan berpotensi menurunkan kepuasan pasien. Kepatuhan Waktu Visit Dokter: Kepatuhan terhadap waktu visit yang ditetapkan (06.00 – 14.00 WIB) hanya mencapai 75,01%, memengaruhi kualitas asuhan medis dan kesinambungan pelayanan. Sementara itu, beberapa indikator yang telah mencapai hasil baik (seperti Identifikasi Pasien 99,48%, APD 90,51%, dan Pencegahan Cedera Pasien Jatuh 97,62%) harus terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui monitoring ketat.

Data IKP periode Januari hingga Oktober 2025 menunjukkan adanya kasus-kasus risiko yang terulang seperti KPC (Kejadian Potensial Cedera) Rekam Medis Ganda dan KNC (Kejadian Nyaris Cedera) terkait Medikasi yang terulang setiap bulan. Mengenai pelaporan insiden keselamatan pasien, rumah sakit telah menunjukkan kematangan dalam fase pelaporan. Insiden- insiden ini telah dilaporkan, diinvestigasi, dan Komite PMKP telah menyelesaikan Root Cause Analysis (RCA) secara formal. Namun, nilai dari investigasi mendalam ini menjadi nihil karena ditemukan kelemahan kritis pada tahap akhir proses: Tindak Lanjut Perbaikan yang Dihasilkan dari RCA/Investigasi Seringkali Tidak Terlaksana atau berhenti di Tingkat Unit Operasional. Kegagalan implementasi ini juga ditambah dengan kelemahan pada manajemen risiko proaktif, di mana follow-up tindak lanjut dari *risk register* yang sudah dibuat belum dilaksanakan secara konsisten.

Adapun terkait hasil budaya keselamatan pasien tahun 2025 rata – rata capaian secara keseluruhan sebesar 85,85% yang menunjukkan modal budaya yang baik. Namun dari 10 dimensi budaya keselamatan terdapat 3 dimensi yang menjadi prioritas utama dalam intervensi program kerja. Pertama, yakni dimensi pelaporan kejadian keselamatan pasien dengan capaian 76,72% yang menunjukkan adanya hambatan sistemik (formulir/proses yang rumit) mereka lebih memilih menyelesaikan masalah secara informal (di unit) daripada mencatatnya, sehingga rumah sakit kehilangan data krusial tentang *Near Miss* (KNC) yang seharusnya menjadi bahan pembelajaran sistem. Kedua, yakni dimensi serah terima dan pertukaran informasi dengan capaian 77,73%, rendahnya koordinasi saat transisi perawatan (antar-shift atau antar-unit), yang merupakan sumber utama *medication error* dan insiden klinis. Ketiga yakni dimensi respon terhadap error yakni dengan capaian 78,81% yang menunjukkan kelemahan dalam siklus umpan balik (*feedback loop*), dan staf merasa tindak lanjut manajerial terhadap laporan insiden kurang transparan, berpotensi mengikis kepercayaan dan mengurangi motivasi pelaporan di masa depan.

Berdasarkan data Indikator Mutu Nasional (IMN) dan kegagalan di tingkat implementasi baik pada manajemen risiko, Program Kerja Komite PMKP ini disusun sebagai strategi rekayasa ulang sistem yang terfokus. Program ini bertujuan utama untuk memperbaiki Krisis Umpan Balik dengan menjamin implementasi rekomendasi RCA/investigasi dan *Risk Register* secara transparan. Selain itu, program akan berfokus pada penutupan kesenjangan kinerja pada Kebersihan Tangan dan Efisiensi Waktu Tunggu melalui penguatan pada dimensi budaya Pelaporan, Serah Terima, dan Respon terhadap *error*. Dengan demikian, program ini akan mentransformasikan risiko menjadi pembelajaran sistemik, menjamin keselamatan pasien, dan menjaga kepercayaan publik.

1.2 Dasar Hukum

- 1.2.1. Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- 1.2.2. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- 1.2.3. Undang – Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- 1.2.4. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Praktik Kedokteran
- 1.2.5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- 1.2.6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit
- 1.2.7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berbasis Risiko
- 1.2.8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan
- 1.2.9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit
- 1.2.10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan
- 1.2.11. Peraturan Menteri Kesehatan No 80 Tahun 2020 tentang Komite Mutu Rumah Sakit
- 1.2.12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
- 1.2.13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis

-
- 1.2.14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran
 - 1.2.15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien
 - 1.2.16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Indikator Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah
 - 1.2.17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis (Elektronik)
 - 1.2.18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit
 - 1.2.19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan
 - 1.2.20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit
 - 1.2.21. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - 1.2.22. Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Nomor 463/RSPHS/I-PER/DIR/VI/2025 tentang Pedoman Kerja Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
 - 1.2.23. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit
 - 1.2.24. Keputusan Menteri Kesehatan No.HK.01.07/MENKES/174 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kesehatan Prioritas
 - 1.2.25. Keputusan Direktorat Jendral No HK.02.02.D.43961.2024 tentang Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit
 - 1.2.26. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1354/2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Kesehatan
 - 1.2.27. Keputusan Direktur Utama Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 773.145/I-KEP/DIR/VI/2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Rumah Sakit Prima Husada
 - 1.2.28. Keputusan Direktur Utama Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 262/DPM/I-KEP/DIR/VII/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan program kerja Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) ini adalah:

1. Tersedianya kerangka kerja (framework) dan panduan operasional yang terencana, terstruktur, dan berkelanjutan bagi Komite PMKP dan seluruh unit kerja di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo
2. Memastikan implementasi kewajiban peningkatan mutu dan keselamatan pasien sebagai pemenuhan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Standar Akreditasi Rumah Sakit

1.3.2 Tujuan Umum

1. Meningkatkan mutu pelayanan di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo sesuai dengan standar indikator yang ada.
2. Menjamin terlaksananya sistem tata kelola PMKP yang transparan dan akuntabel dengan memastikan implementasi perbaikan sistemik dari insiden keselamatan pasien dan manajemen risiko, demi menjaga kepercayaan publik.
3. Membangun budaya keselamatan pasien yang proaktif dengan memperkuat dimensi Pelaporan, Serah Terima, dan Respon terhadap *Error*, untuk mencapai standar *excellent service*.

1.3.3. Tujuan Khusus

1. Tercapainya peningkatan tingkat kepatuhan kebersihan tangan (IMN) dari 79,16% menjadi minimal 85% untuk mendukung pencegahan HAIs
2. Tercapainya peningkatan efisiensi pelayanan melalui kenaikan capaian Waktu Tunggu Rawat Jalan (IMN) dari 71,23% menjadi minimal 80%.
3. Tercapainya peningkatan kepatuhan Waktu Visit Dokter (06.00 – 14.00 WIB) dari 75,01% menjadi minimal 80% guna menjamin kesinambungan asuhan medis.
4. Terpertahankannya kinerja indikator mutu yang sudah baik (Identifikasi Pasien, APD, dan Pencegahan Cedera Pasien Jatuh) pada capaian di atas 95% melalui *monitoring* berkala.
5. Terukur dan Tercapainya tingkat kepatuhan penggunaan Clinical Pathway (CP) pada kasus prioritas minimal 80%, sebagai upaya mengurangi variasi pelayanan dan memastikan *outcome* klinis yang optimal.
6. Tercapainya tingkat implementasi minimal 90% terhadap semua rekomendasi perbaikan yang dihasilkan dari RCA dan investigasi insiden, didukung dengan sistem *tracking* implementasi yang transparan dan akuntabel
7. Terlaksananya tindak lanjut perbaikan sistemik untuk kasus risiko yang terulang (Rekam Medis Ganda dan KNC Medikasi), dengan target penurunan frekuensi kejadian hingga 50%
8. Terlaksananya tindak lanjut dari *Risk Register* (daftar risiko) secara konsisten dan terdokumentasi, sebagai upaya mitigasi potensi risiko tinggi secara proaktif.
9. Tercapainya peningkatan dimensi Pelaporan Kejadian Keselamatan Pasien dari 76,72% menjadi minimal 85%
10. Terlaksananya standarisasi komunikasi serah terima pasien melalui implementasi protokol terstandar (misalnya SBAR), sehingga dimensi Serah Terima dan Pertukaran Informasi meningkat dari 77,73% menjadi minimal 85%
11. Terwujudnya budaya tidak menghukum (*Just Culture*) melalui pelatihan manajer unit, sehingga dimensi Respon terhadap *Error* meningkat dari 78,81% menjadi minimal 85%, dan kepercayaan staf terhadap tindak lanjut manajerial meningkat
12. Tercapainya peningkatan rata-rata capaian budaya keselamatan pasien secara keseluruhan dari 85,85% menjadi minimal 90% pada survei budaya tahunan berikutnya
13. Terlaksananya program pelatihan PMKP dengan minimal 80% total staf untuk meningkatkan kompetensi.
14. Tercapainya integrasi sistem pengumpulan, validasi, dan analisis data mutu (minimal 80% data IMN terinput dan tervalidasi setiap bulan) untuk memfasilitasi pengambilan keputusan dan evaluasi berbasis data.

BAB II
GAMBARAN UMUM

2.1. Visi

Menjadi rumah sakit berkualitas prima pilihan seluruh lapisan masyarakat.

2.2. Misi

- 1. Memberikan pelayanan kesehatan dengan aman, tepat, cepat dan akurat.
- 2. Mengutamakan kepuasan dan keselamatan pasien
- 3. Meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan

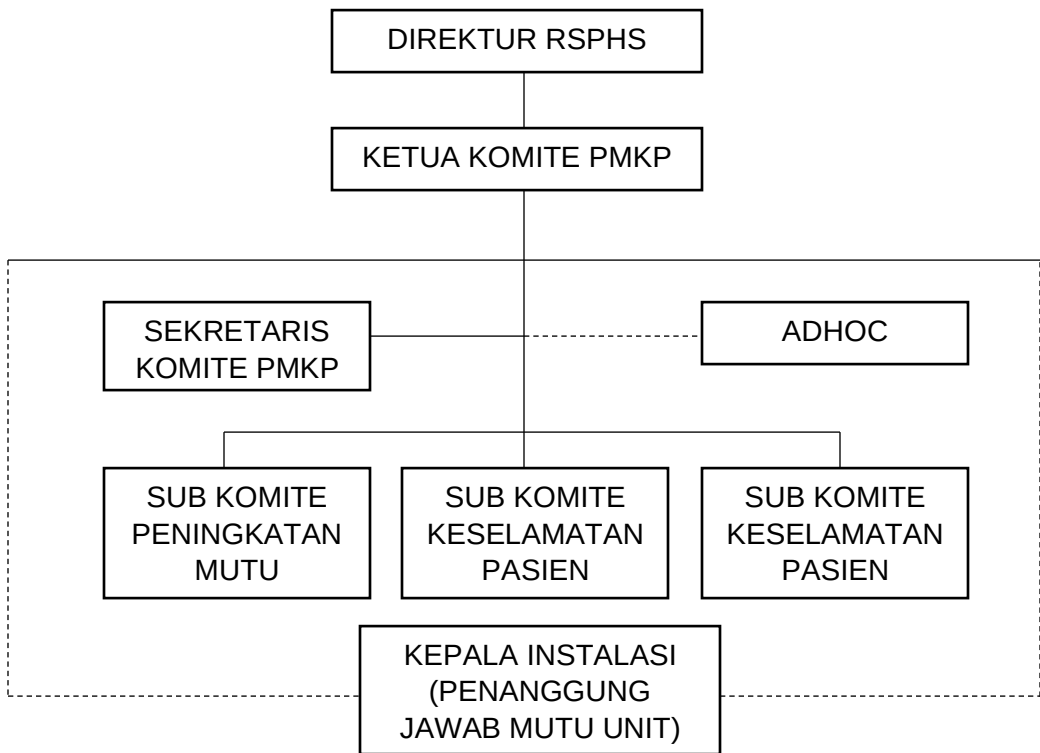
2.3. Motto

Sahabat Menuju Sehat

2.4. 7 Nilai Budi Utama

- 1. Jujur + Dipercaya
- 2. Tanggung Jawab
- 3. Visioner
- 4. Disiplin
- 5. Kerja sama
- 6. Adil
- 7. Peduli

2.5. SOTK Komite PMKP



2.6. Permasalahan kinerja tahun 2025

No	Permasalahan	Capaian	Target yang Diharapkan
1	Capaian Kepatuhan Kebersihan Tangan bulan Januari sampai Bulan Oktober 2025 masih di bawah standar dan berpotensi meningkatkan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan (HAIS)	79,16%	≥85%
2	Capaian Waktu tunggu pasien di Rawat Jalan sangat rendah, mengindikasikan alur pelayanan tidak efisien dan berpotensi menurunkan	71,23%	≥80%

No	Permasalahan	Capaian	Target yang Diharapkan
	kepuasan pasien secara signifikan		
3	Clinical Pathway pengisian yang patuh hanya di Unit Maternitas	Hanya maternitas yang melakukan pengisian cp dengan rata-rata kepatuhan 98,86%	Semua unit yang memiliki diagnosa tunggal bisa dilakukan evaluasi clinical pathway
4	Kepatuhan terhadap jadwal visit dokter yang telah ditetapkan masih rendah, memengaruhi kualitas asuhan medis dan kesinambungan informasi.	75,01%	≥80%
5	Kasus KPC Rekam Medis Ganda dan KNC Medikasi terulang setiap bulan.		Penurunan ≤50%
6	<i>Follow-up</i> tindak lanjut dari <i>Risk Register</i> belum dilaksanakan secara konsisten		Dilakukan secara konsisten
7	Standarisasi Komunikasi Serah Terima	77,73%	≥85%
8	Pelaporan insiden Keselamatan Pasien belum maksimal	76,72%	≥85%

BAB III
KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN

3.1. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan

No	KEGIATAN POKOK	RINCIAN KEGIATAN
1.	Pemenuhan Kebutuhan SDM	Pembuatan usulan ketua Komite Mutu RSPHS: 1 orang dokter
2.	Orientasi	- Persiapan orientasi - Pelaksanaan orientasi - Monev & pelaporan hasil orientasi
3	Pendidikan dan Pelatihan (Seminar dan Workshop) terkait Mutu	- Pelatihan Eksternal: - Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) dan Manajemen Resiko - Penyusunan Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) dan Root Cause Analysis (RCA) - Implementasi Kendali Mutu Biaya pada bab PMKP - Pelatihan Internal: <i>Refreshment & Training</i> PMKP - Pelatihan Pengambilan Data Mutu (PIC): - Materi: - Refreshment Indikator Mutu yang berlaku di Unit - Alur Pengumpulan Data Mutu baik di SIMRS maupun <i>Google Spreadsheet</i> - Cara analisa permasalahan sesuai dengan kondisi di unit sampai dengan tindak lanjut perbaikan - Praktik mengumpulkan data Mutu baik di SIMRS maupun <i>Google Spreadsheet by name</i> - Praktik mengunduh laporan mutu di SIMRS - Pelatihan terkait pengisian CP di Unit: (Kolaborasi dengan Komite Medik) - Sasaran: PPA (Program Pemberi Asuhan) yakni DPJP, Perawat, Bidan, Gizi dan Farmasi - Materi: - Refreshment Praktik Klinis yang dilakukan Audit - Pengisian Form CP di <i>Google Spreadsheet</i>
4.	Perencanaan Mutu RS	- Review & Revisi Regulasi Mutu - SK Komite Mutu - Perdir - Pedoman Mutu RS - SK PJ.& Validator Mutu Unit - SK PIC Data Mutu Unit

No	KEGIATAN POKOK	RINCIAN KEGIATAN
		e. SK Sistem Pelaporan dan Pembelajaran Keselamatan Pasien Rumah Sakit (SP2KP RS) f. SPO 2. Membuat Program kerja : a. Program Mutu RS (PMKP, Keselamatan Pasien, Manajemen Risiko) 3. Pengumpulan dan analisis data tahun 2025 sebagai bahan untuk pemilihan indikator Mutu tahun 2026
5.	Penetapan Indikator Mutu	1. Pengumpulan usulan mutu unit 2. Rapat koordinasi penentuan mutu Unit 3. Rapat penetapan IMPRS 4. Penetapan dan pengesahan Indikator Mutu RS
6.	Pelaksanaan Pengukuran Mutu RS	1. Validasi data oleh Komite atau Direktur sesuai standard 2. Penerimaan data mutu dari unit 3. Rekapitulasi data di mutu Tingkat RS dan analisa data 4. Membuat rencana perbaikan & pelaksanaan perbaikan 5. Feedback Hasil pengukuran Mutu ke Unit
7.	Monev (Monitoring/pemantauan dan Evaluasi) Mutu	1. Memantau pengumpulan dan analisa data di masing-masing unit (INM, IMP-RS, IMP– Unit) 2. Memantau Validasi data oleh PJ Mutu Unit sesuai standard
8.	Pelaporan Mutu	1. Pelaporan Mutu RS ke Direktur RS 2. Pelaporan Mutu RS ke PT.DPM 3. Benchmark Mutu antar RS Tipe C 4. Pelaporan Mutu RS ke Kemenkes (SIMAR) 5. Pelaporan Mutu RS ke Dinkes Kab. Pasuruan
9.	Penerapan Standar Pelayanan Kedokteran di Rumah Sakit (PPK-CP)	1. Evaluasi CP dengan Komite Medik 2. Audit medis dengan Pimpinan Medis dan Komite Medik 3. Rapat koordinasi hasil monitoring dan audit medis PPK - CP
10.	Pelaksanaan Pengukuran Budaya Keselamatan	1. Pengukuran budaya keselamatan 2. Analisa dan tindak lanjut hasil budaya keselamatan 3. Pelaporan hasil budaya Keselamatan ke Direktur RS 4. Pelaporan budaya Keselamatan RS ke PT.DPM 5. Penyusunan program budaya keselamatan untuk tahun berikutnya
11.	Pelaksanaan Pengukuran Manajemen Risiko	1. Penyusunan identifikasi risiko ditingkat unit dan tingkat RS 2. Penyusunan Risk register 3. Penyusunan strategi untuk menurunkan risiko 4. Monitoring dan evaluasi terhadap risiko di unit

No	KEGIATAN POKOK	RINCIAN KEGIATAN
		5. Pelaporan hasil monitoring kepada direktur dan representative pemilik 6. Penyusunan FMEA 7. Monitoring tindak lanjut FMEA 8. Pelaporan FMEA ke Direktur RS

3.2. Sasaran

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
1.	SDM						
	Pembuatan usulan ketua Komite Mutu RSPHS: 1 orang dokter	Optimalisasi program & strategi pelaksanaan PMKP	Dokter Umum	Rekrutmen	Terpenuhi	Penambahan 1 staff untuk Ketua Komite PMKP	-
2.	Orientasi						
	1. Persiapan orientasi 2. Pelaksanaan orientasi 3. Monev & pelaporan hasil orientasi	Meningkatkan pengetahuan karyawan baru terkait program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) di RS Prima Husada Sukorejo	Karyawan Baru	Pembelajaran Kontekstual	Terpenuhi	1. 100% karyawan baru mengikuti pelatihan 2. 100% karyawan baru yang mengikuti pelatihan mengalami peningkatan pengetahuan & keterampilan	
3.	Pendidikan dan Pelatihan (Seminar dan Workshop) terkait Mutu						
a.	Pelatihan Eksternal						

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
	1) Pelatihan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) dan Manajemen Resiko	Meningkatkan pengetahuan, softskill dalam manajerial tim PMKP	1. Ketua PMKP 2. Sekretaris PMKP 3. Ketua Sub Komite Peningkatan Mutu 4. Ketua Sub Keselamatan Pasien 5. Ketua Sub Manajemen Risiko	Diklat	1 kali dalam setahun	1. Peserta mampu menyusun minimal 1 rencana kerja PMKP (program mutu, keselamatan pasien, atau risiko) dalam 1 bulan pasca pelatihan. 2. Seluruh peserta mengalami peningkatan pengetahuan, dibuktikan dengan Peningkatan nilai post-test minimal 20%	Diklat diselenggarakan oleh KARS
	2) Pelatihan Penyusunan Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) dan Root Cause Analysis (RCA)	Meningkatkan pengetahuan, softskill dalam manajerial tim PMKP	1. Ketua PMKP 2. Sekretaris PMKP 3. Ketua Sub Keselamatan Pasien	Diklat	1 kali dalam setahun	1. Peserta mampu menyusun minimal 1 dokumen FMEA lengkap, meliputi: a. Identifikasi mode kegagalan b. Penilaian tingkat keparahan–kejadian–deteksi	Diklat diselenggarakan oleh KARS

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
						c. RPN & rekomendasi perbaikan 2. Seluruh peserta mengalami peningkatan pengetahuan, dibuktikan dengan Peningkatan nilai post-test minimal 20%	
	3) Pelatihan Implementasi Kendali Mutu Biaya pada bab PMKP	Meningkatkan pengetahuan, softskill dalam manajerial tim PMKP	1. Ketua Komite PMKP 2. Sekretaris PMKP 3. Ketua Sub Komite Peningkatan Mutu	Diklat	1 kali dalam setahun	1. Peserta mampu menyusun minimal 1 indikator mutu biaya 2. Seluruh peserta mengalami peningkatan pengetahuan, dibuktikan dengan Peningkatan nilai post-test minimal 20%	Diklat diselenggarakan oleh KARS
b.	Pelatihan Internal						
	1) <i>Refreshment & Training</i> PMKP Materi: a) Indikator Mutu Nasional, Indikator Mutu Prioritas RS, Indikator Mutu Unit	Memperkuat dan memperbarui pengetahuan serta keterampilan terkait program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) di	All Staff	Sosialisasi & Pelatihan	100% karyawan	1. 100% karyawan mengikuti pelatihan 2. 100% karyawan yang mengikuti pelatihan mengalami peningkatan	

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
	b) Macam-macam Insiden Keselamatan Pasien dan Alur Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien dan Budaya Keselamatan Pasien c) Manajemen Resiko	RS Prima Husada Sukorejo				pengetahuan & keterampilan	
	2) Pelatihan Pengambilan Data Mutu Materi: a) Refreshment Indikator Mutu yang berlaku di Unit b) Alur Pengumpulan Data Mutu baik di SIMRS maupun <i>Google Spreadsheet</i> c) Cara analisa permasalahan sesuai dengan kondisi di unit sampai dengan tindak lanjut perbaikan d) Praktik mengumpulkan data Mutu baik di SIMRS maupun <i>Google</i>	Meningkatnya kemampuan PIC Mutu Unit dalam pengumpulan data, analisa data, dan interpretasi data	PIC Mutu Unit	Pelatihan Internal	1 kali dalam setahun	1. Semua PIC dapat mengumpulkan, menganalisa dan menginterpretasi indikator mutu unit nya 2. Semua PIC mutu mendapatkan sertifikat pelatihan pengambilan data mutu	

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
	<i>Spreadsheet by name.</i> e) Praktik mengunduh laporan mutu di SIMRS						
	3) Pelatihan terkait pengisian CP di Unit Materi: a) Refreshment Praktik Klinis yang dilakukan Audit b) Pengisian Form CP di Google Spreadsheet	Meningkatnya kemampuan PPA (Profesional Pemberi Asuhan) pengumpulan data, analisa data, dan interpretasi data	Karu Rawat Inap, Dokter, Gizi, Farmasi	Pelatihan Internal	1 kali dalam setahun	1. Semua PPA dapat mengisi Form CP 2. Semua PPA mendapatkan sertifikat pelatihan pengisian CP	
4.	Perencanaan Mutu RS						
	Regulasi terkait Komite Mutu. Regulasi di review dan di buat sesuai dengan peraturan yang berlaku, tidak ada regulasi yang <i>expired</i> . Regulasi yang perlu di review yakni: 1. Penetapan SK Komite Mutu 2. Penetapan SK PJ Mutu 3. Penetapan SK PIC Mutu 4. Penetapan SK Validator Mutu 5. Penetapan Pedoman Komite Mutu RS	Memperbarui regulasi mutu sesuai dengan undang-undang / PMK yang berlaku	Komite PMKP	Review Dokumen Regulasi	1 kali dalam setahun	Regulasi dapat terbaru sesuai UU/PMK/Pedoman Terbaru	

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
	6. Penetapan Program Kerja Komite Mutu RS 7. Penetapan tentang Sistem Pelaporan dan Pembelajaran Keselamatan Pasien Rumah Sakit (SP2KP RS) 8. Penetapan tentang Program Budaya Keselamatan Rumah Sakit 9. Penetapan tentang Program Manajemen Risiko Tingkat Rumah Sakit						
10.	Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM). Indikator Nasional Mutu adalah indikator mutu nasional yang wajib dilakukan pengukuran dan digunakan sebagai informasi mutu secara nasional. Adapun Indikator Nasional Mutu (INM) adalah sebagai berikut: 1. Kepatuhan kebersihan tangan ($\geq 85\%$)	Sebagai tolak ukur kepatuhan dan bahan analisa capaian RS dalam menjalankan INM	Setiap Unit di RS	Observasi lapangan	Setiap bulan	Indikator Nasional Mutu terlaksana dengan data real dan sesuai dengan kondisi lapangan	

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
	2. Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (100%) 3. Kepatuhan identifikasi pasien (100%) 4. Waktu tanggap operasi seksio sesarea emergensi (>80%) 5. Waktu tunggu rawat jalan ($\geq 80\%$) 6. Penundaan operasi elektif (<5%) 7. Kepatuhan waktu visite dokter ($\geq 80\%$) 8. Pelaporan hasil kritis laboratorium (100%) 9. Kepatuhan penggunaan formularium nasional ($\geq 80\%$) 10. Kepatuhan terhadap alur klinis (<i>Clinical Pathway</i>) ($\geq 80\%$) 11. Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh (100%) 12. Kecepatan waktu tanggap komplain ($\geq 80\%$)						

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
	13. Kepuasan pasien (76.61%) Adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut: - Terlaksananya pengumpulan dan analisa data - Terlaksananya pelaporan indikator mutu Nasional ke Aplikasi SIMAR - Terlaksananya rencana perbaikan & pelaksanaan perbaikan - Terlaksananya monitoring indikator nasional mutu						
11.	Pengukuran Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit (IMP-RS) Direkur beserta Komite Mutu RS. Prima Husada Sukorejo melakukan persiapan berupa pertemuan atau rapat dengan seluruh kepala ruangan, sehingga ada kesamaan pengertian tentang mutu, keselamatan pasien dan manajemen risiko sehingga ditemukan	Memilih Indikator Mutu Prioritas RS 2026 pada tahun 2025, untuk dilakukan target perbaikan pada tahun 2026	Pelayanan Bedah	FGD (<i>Focus Group Discussion</i>)	- Penentuan IMP RS dilakukan 1 kali dalam setahun - Pengambilan data IMP RS dilakukan setiap hari - Pelaporan Capaian Indikator Mutu dilakukan setiap bulan	- Indikator Mutu Prioritas RS terlaksana dengan data real dan sesuai dengan kondisi lapangan - Adanya SK penetapan Indikator Mutu Prioritas RS	

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
	kesepakatan tentang langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan. 2. Pemilihan Indikator Mutu Prioritas RS (IMP-RS) dan sesuai dengan TKRS 5 mencakup: a. Indikator Sasaran Keselamatan Pasien (ISKP) b. Indikator Pelayanan Klinis Prioritas c. Indikator sesuai Tujuan Strategis Rumah Sakit (KPI) d. Indikator terkait Perbaikan Sistem e. Indikator terkait Manajemen Risiko 3. Indikator pelayanan klinis prioritas ditetapkan melalui SK penetapan direktur. 4. Terlaksananya pengumpulan data, analisa, interpretasi data dan <i>feedback</i> data 5. Terlaksananya pelaporan capaian indikator mutu prioritas RS						

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
12.	Pengukuran Indikator Mutu Prioritas Unit Indikator Mutu Prioritas Unit (IMP – Unit) adalah indikator prioritas yang khusus dipilih kepala unit terdiri dari minimal 1 indikator. Adapun uraiannya sebagai berikut: 1. Terlaksananya pemilihan Indikator Mutu Unit 2. Terlaksananya penetapan Indikator Mutu Unit a. IGD b. Instalasi Rawat Jalan c. Instalasi Rawat Inap 2A d. Instalasi Rawat Inap 2B e. Instalasi Rawat Inap 3A f. Instalasi Rawat Inap 3B g. Instalasi Kamar Operasi h. Maternitas i. Ponak j. Neonatologi k. ICU l. Hemodialisa	Memilih Indikator Mutu Prioritas Unit 2026 pada tahun 2025, untuk dilakukan target perbaikan pada tahun 2026	Setiap unit di RS	FGD	1. Penentuan IMP Unit dilakukan 1 kali dalam setahun 2. Pengambilan data IMP Unit dilakukan setiap hari 3. Pelaporan Capaian Indikator Mutu dilakukan setiap bulan	1. Indikator Mutu Prioritas Unit terlaksana dengan data real dan sesuai dengan kondisi lapangan 2. Adanya SK penetapan Indikator Mutu Prioritas Unit	

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
	m. Radiologi n. Laboratorium o. Rehab Medis p. Farmasi q. Gizi r. Rekam Medis s. Limbah-K3RS t. SDM u. Kesekretariatan v. Driver w. Pemulasaran Jenazah x. ATEM-IPSRS y. Laundry z. CSSD aa. Cleaning Service bb. Keamanan cc. Gudang Umum dd. PPI ee. PKRS ff. Verifikator gg. Humas & Marketing hh. MOD-MPP-PIPP ii. TB di IRJA jj. Keuangan kk. HIV ll. KB mm. Stunting nn. IT-SIMRS 3. Terlaksananya pengumpulan dan analisa data						

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
	4. Terlaksananya pelaporan indikator mutu unit 5. Terlaksananya rencana perbaikan & pelaksanaan perbaikan 6. Terlaksananya monitoring mutu unit kerja						
13.	Analisa, Pelaporan dan <i>feedback</i> data indikator mutu terintegrasi 1. Terlaksananya pengumpulan data indikator mutu oleh PIC di setiap unit kerja sesuai dengan profil indikator 2. Terlaksananya analisa data pencapaian indikator sesuai dengan ketentuan analisa data 3. Terlaksananya validasi data sesuai dengan ketentuan validasi data 4. Terlaksananya pelaporan data indikator mutu dari tingkat unit sampai dengan ke pemilik 5. Terlaksananya penyampaian <i>feedback</i>	Untuk mendata setiap indikator yang berlaku di setiap unit sebagai bahan yang digunakan untuk menganalisis perbaikan / berburukan dan dilakukan tindak lanjut dan <i>feedback</i> perbaiki kepada setiap unit	Setiap unit di RS	Observasi lapangan & Analisa data	1. Terlaksana 100% 2. Terlaksana 100% 3. Terlaksana 100% 4. Terlaksana 100% 5. Terlaksana 100% 6. Terlaksana 100% 7. Terlaksana 100%	Terlaksananya tindak lanjut untuk setiap unit yang melaporkan capaiannya	

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
	hasil capaian indikator mutu ke semua staf di unit kerja 6. Terlaksananya publikasi data indikator mutu. 7. Terlaksananya <i>benchmark</i> data						
14.	Penerapan Standar Pelayanan Kedokteran di Rumah Sakit. Terkait dengan pengukuran prioritas perbaikan pelayanan klinis yang ditetapkan oleh Direktur, maka direktur bersama-sama dengan pimpinan medis, ketua komite medik menetapkan paling sedikit 5 evaluasi pelayanan prioritas standar pelayanan kedokteran. 1. Terlaksananya evaluasi CP dengan Komite Medik 2. Terlaksananya audit medis dengan Pimpinan Medis dan Komite Medik	1. Untuk menilai efektivitas penerapan standar pelayanan kedokteran di rumah sakit 2. Untuk mengurangi variasi dari proses, hasil dan efisiensi biaya	1. PPA (Profesional Pemberi Asuhan) yakni: a. DPJP b. Perawat/Bidan c. Gizi d. Farmasi 2. Komite PMKP 3. Komite Medik	Observasi lapangan & Analisa data	1 bulan sekali	Terlaksananya audit medis di setiap pelayanan prioritas standar pelayanan kedokteran	
15.	Sistem pelaporan dan pembelajaran keselamatan pasien di rumah sakit (SP2KP-RS) meliputi	Sebagai bentuk partisipasi dan kepedulian petugas dalam	Setiap unit di RS	Laporan IKP	1. Terlaksana setiap kali terjadi insiden	setiap IKP dilaporkan < 2 x 24 jam terutama KPC yang terjadi di unit	

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
	kejadian sentinel, Kejadian yang Tidak Diharapkan (KTD), Kejadian Tidak Cedera (KTC), Kejadian Nyaris Cedera (KNC) dan Kejadian Potensial Cedera (KPC). Mekanisme pelaporan insiden keselamatan pasien baik internal maupun eksternal, grading matriks risiko serta investigasi dan analisa insiden berdasarkan hasil grading. Adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut: 1. Terlaksananya pelaporan IKP secara internal ke tim KPRS 2. Terlaksananya investigasi dan perbaikan berdasarkan risk matrix grading 3. Terlaksana pelaporan IKP ke representative pemilik 4. Terlaksananya pelaporan IKP secara eksternal ke KNKP	meningkatkan budaya lapor IKP yang terjadi di unitnya dan sebagai bukti bahwa RS telah memprioritaskan keselamatan pasien			2. Terlaksana setiap kali terjadi insiden 3. Terlaksana setiap 3 bulan sekali 4. Terlaksana setiap bulan sekali		

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
16.	Pengukuran budaya keselamatan pasien perlu dilakukan oleh RS dengan melakukan survei budaya keselamatan pasien setiap tahun. Adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut: 1. Terlaksananya pengukuran budaya keselamatan 2. Terlaksananya analisa dan tindak lanjut hasil budaya keselamatan	untuk mengukur tingkat budaya keselamatan pasien dan Menyusun program kerja keselamatan pasien pada tahun berikutnya	All Staf di RS Prima Husada Sukorejo	Survey	1 kali dalam setahun	Pengukuran dapat terlaksana dan dilaporkan kepada direktur & PT 1 kali dalam setahun	
17.	Komite Mutu membuat daftar resiko tingkat rumah sakit berdasarkan daftar risiko yang dibuat tiap unit setiap tahun. Adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut: 1. Melakukan identifikasi risiko ditingkat unit dan tingkat RS 2. Menyusun Risk register 3. Menyusun strategi untuk menurunkan risiko 4. Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap risiko di unit	untuk menghindari risiko yang dimiliki di unit agar dapat terminimalisasi kejadiannya dan menganalisis alur sebelum insidennya terjadi	Setiap unit di RS	Observasi dan analisa	1 kali dalam setahun	Tercatatnya risiko yang terjadi di setiap unit dan pengendalian risiko di unit dapat dilaksanakan sesuai dengan hasil pada risk register	

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
	5. Terlaksananya pelaporan hasil monitoring kepada direktur dan representative pemilik 6. Menyusun FMEA 7. Melakukan monitoring tindak lanjut FMEA						

a. **Cara Melaksanakan Kegiatan**

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
1.	Penambahan Ketua Komite PMKP full time (diutamakan dengan latar pendidikan Dokter Umum)	1. Pengajuan SDM 2. Rekrutmen Staff	Seleksi Kompetensi	Media Poster	Januari 2026	1. Poster Rekrutmen 2. Kontrak Kerja 3. SK Pegawai	
2.	Pelatihan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) dan Manajemen Resiko	1. Pengajuan pelatihan eksternal ke SDM	Diklat Eksternal	- Google Zoom - Datang langsung ke penyelenggaraan pelatihan	Tentatif (Menyesuaikan Jadwal dari KARS)	1. Surat Tugas 2. Sertifikat 3. Materi 4. Laporan	
3.	Pelatihan Penyusunan Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) dan Root Cause Analysis (RCA)	Pengajuan pelatihan eksternal ke SDM	Diklat Eksternal	- Google Zoom Datang langsung ke penyelenggaraan pelatihan	Tentatif (Menyesuaikan Jadwal dari KARS)	1. Surat Tugas 2. Sertifikat 3. Materi 4. Laporan	
4.	Pelatihan Implementasi Kendali Mutu Biaya pada bab PMKP	Pengajuan pelatihan eksternal ke SDM	Diklat Eksternal	- Google Zoom Datang langsung ke penyelenggaraan pelatihan	Tentatif (Menyesuaikan Jadwal dari KARS)	1. Surat Tugas 2. Sertifikat 3. Materi 4. Laporan	

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
5.	Orientasi Umum - Pengenalan Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) di RS Prima Husada Sukorejo	1. Undangan 2. Pelaksanaan 3. LPJ	Diklat Internal	- PPT	Tentatif (Menyesuaikan Jadwal dari Perekrutan SDM)	1. UMANDOK 2. Hasil Pre & Post Test 3. LPJ	
6.	<i>Refreshment & Training</i> PMKP Materi: 1. Indikator Mutu Nasional, Indikator Mutu Prioritas RS, Indikator Mutu Unit 2. Macam-macam Insiden Keselamatan Pasien dan Alur Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien dan Budaya Keselamatan 3. Manajemen Resiko	1. Pengajuan TOR 2. Pelaksanaan 3. LPJ	Diklat Internal	- PPT	Bulan Juni 2026 Bulan Desember 2026	1. TUMANDOK 2. Hasil Pre & Post Test 3. Sertifikat 4. LPJ	
7.	Pelatihan Pengambilan Data Mutu Materi: 1. Refreshment Indikator Mutu yang berlaku di Unit 2. Alur Pengumpulan Data Mutu baik di SIMRS maupun <i>Google Spreadsheet</i> 3. Cara analisa permasalahan sesuai dengan kondisi di unit	1. Undangan 2. Pelaksanaan 3. LPJ	Diklat Internal	- PPT - SIMRS - Google Spreadsheet	Bulan Januari 2026	1. UMANDOK 2. Hasil Pre & Post Test 3. LPJ	

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
	sampai dengan tindak lanjut perbaikan 4. Praktik mengumpulkan data Mutu baik di SIMRS maupun <i>Google Spreadsheet by name</i> . 5. Praktik mengunduh laporan mutu di SIMRS						
8.	Pelatihan terkait pengisian CP di Unit Materi: 1. Refreshment Praktik Klinis yang dilakukan Audit 2. Pengisian Form CP di Google Spreadsheet	1. Pengajuan TOR 2. Pelaksanaan 3. LPJ	Diklat Internal	- PPT - Google Spreadsheet	Bulan Januari 2026	1. TUMANDOK 2. Hasil Pre & Post Test 3. Sertifikat 4. LPJ	
9.	Regulasi terkait Komite Mutu. Regulasi di review dan di buat sesuai dengan peraturan yang berlaku, tidak ada regulasi yang <i>expired</i> . Regulasi yang perlu di review yakni: 1. Penetapan SK Komite Mutu 2. Penetapan SK PJ Mutu 3. Penetapan SK PIC Mutu 4. Penetapan SK Validator Mutu	Membandingkan peraturan baru dan pedoman / SPO / Alur yang dimiliki oleh komite mutu	Review dokumen	Pedoman	Bulan Januari 2026	Perbaikan regulasi	

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
	5. Penetapan Pedoman Komite Mutu RS 6. Penetapan Program Kerja Komite Mutu RS 7. Penetapan tentang Sistem Pelaporan dan Pembelajaran Keselamatan Pasien Rumah Sakit (SP2KP RS) 8. Penetapan tentang Program Budaya Keselamatan Rumah Sakit 9. Penetapan tentang Program Manajemen Risiko Tingkat Rumah Sakit						
10.	Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM). Indikator Nasional Mutu adalah indikator mutu nasional yang wajib dilakukan pengukuran dan digunakan sebagai informasi mutu secara nasional. Adapun Indikator Nasional Mutu (INM) adalah sebagai berikut: 1. Kepatuhan kebersihan tangan ($\geq 85\%$)	Melakukan pemantauan secara berkesinambungan melalui pengecekan pengambilan data, kevalidan dari lembar laporan harian kepada setiap kepala ruangan	Observasi lapangan	Instrumen pangambilan data	Januari – Desember 2026	UMANDOK	

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
	2. Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (100%) 3. Kepatuhan identifikasi pasien (100%) 4. Waktu tanggap operasi seksio sesarea emergensi (>80%) 5. Waktu tunggu rawat jalan ($\geq 80\%$) 6. Penundaan operasi elektif (<5%) 7. Kepatuhan waktu visite dokter ($\geq 80\%$) 8. Pelaporan hasil kritis laboratorium (100%) 9. Kepatuhan penggunaan formularium nasional ($\geq 80\%$) 10. Kepatuhan terhadap alur klinis (<i>Clinical Pathway</i>) ($\geq 80\%$) 11. Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh (100%) 12. Kecepatan waktu tanggap komplain ($\geq 80\%$) 13. Kepuasan pasien (76.61%)						

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
	Adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut: a. Terlaksananya pengumpulan dan analisa data b. Terlaksananya pelaporan indikator mutu Nasional ke Aplikasi SIMAR c. Terlaksananya rencana perbaikan & pelaksanaan perbaikan d. Terlaksananya monitoring indikator nasional mutu						
11.	Pengukuran Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit (IMP-RS): 1. Direkur beserta Komite Mutu RS. Prima Husada Sukorejo melakukan persiapan berupa pertemuan atau rapat dengan seluruh kepala ruangan, sehingga ada kesamaan pengertian tentang mutu, keselamatan pasien dan manajemen risiko sehingga ditemukan kesepakatan tentang langkah-langkah	Diskusi Bersama dengan kepala ruang, PIC, komite dan direksi untuk dilakukan grading dalam menentukan layanan prioritas yang akan di selesaikan pada tahun mendatang	FGD	Diskusi & tanya jawab	Oktober – Desember 2024	UMANDOK	

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
	kegiatan yang akan dilakukan. 2. Pemilihan Indikator Mutu Prioritas RS (IMP-RS) dan sesuai dengan TKRS 5 mencakup: a. Indikator Sasaran Keselamatan Pasien (ISKP) b. Indikator Pelayanan Klinis Prioritas c. Indikator sesuai Tujuan Strategis Rumah Sakit (KPI) d. Indikator terkait Perbaikan Sistem e. Indikator terkait Manajemen Risiko 3. Indikator pelayanan klinis prioritas ditetapkan melalui SK penetapan direktur. 4. Terlaksananya pengumpulan data, analisa, interpretasi data dan <i>feedback</i> data 5. Terlaksananya pelaporan capaian indikator mutu prioritas RS						
12.	Pengukuran Indikator Mutu Prioritas Unit	Diskusi Bersama dengan kepala	FGD	Instrumen pangambilan data	Oktober – Desember 2025	UMANDOK	

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
	Indikator Mutu Prioritas Unit (IMP – Unit) adalah indikator prioritas yang khusus dipilih kepala unit terdiri dari minimal 1 indikator. Adapun uraiannya sebagai berikut: 1. Terlaksananya pemilihan Indikator Mutu Unit 2. Terlaksananya penetapan Indikator Mutu Unit a. IGD b. Instalasi Rawat Jalan c. Instalasi Rawat Inap 2A d. Instalasi Rawat Inap 2B e. Instalasi Rawat Inap 3A f. Instalasi Rawat Inap 3B g. Instalasi Kamar Operasi h. Maternitas i. Ponak j. Neonatologi k. ICU l. Radiologi m. Laboratorium n. Rehab Medis	ruang, PIC, komite dan direksi untuk menjelaskan maslaah yang terjadi di setiap unit, SPM dan memilih masalah yang akan di gunakan sebagai indikator mutu unit pada tahun mendatang					

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
	o. Farmasi p. Gizi q. Rekam Medis r. Limbah-K3RS s. SDM t. Kesekretariatan u. Driver v. Pemulasaran Jenazah w. ATEM-IPSRS x. Laundry y. CSSD z. Cleaning Service aa. Keamanan bb. Gudang Umum cc. PPI dd. PKRS ee. Verifikator ff. Humas & Marketing gg. MOD-MPP-PIPP hh. TB di IRJA ii. Keuangan jj. HIV kk. KB ll. Stunting mm. IT-SIMRS 3. Terlaksananya pengumpulan dan analisa data						
13.	Analisa, Pelaporan dan <i>feedback</i> data indikator mutu terintergrasi	Melakukan pemantauan secara	Observasi lapangan & Analisa data	Instrumen pangambilan data	Januari – desember 2026	UMANDOK	

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
	1. Terlaksananya pengumpulan data indikatotor mutu oleh PIC disetiap unit kerja sesuai dengan profil indikator 2. Terlaksananya analisa data pencapaian indikator sesuai dengan ketentuan analisa data 3. Terlaksananya validasi data sesuai dengan ketentuan validasi data 4. Terlaksananya pelaporan data indikator mutu dari tingkat unit sampai dengan ke pemilik 5. Terlaksananya penyampaian <i>feedback</i> hasil capaian indikator mutu ke semua staf di unit kerja 6. Terlaksananya publikasi data indikator mutu 7. Terlaksananya <i>benchmark</i> data	berkesinambungan melalui pengecekan pengambilan data, kevalidan dari lembar laporan harian kepada setiap kepala ruangan					
14.	Penerapan Standar Pelayanan Kedokteran di Rumah Sakit. Terkait dengan pengukuran prioritas perbaikan pelayanan klinis yang ditetapkan oleh	Melakukan pemantauan CP Pasien dengan membandingkan observasi lapangan	Observasi lapangan & Analisa data	Instrumen pangambilan data	Januari – desember 2026	UMANDOK	

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
	Direktur, maka direktur bersama-sama dengan pimpinan medis, ketua komite medik menetapkan paling sedikit 5 evaluasi pelayanan prioritas standar pelayanan kedokteran. 1. Terlaksananya evaluasi CP dengan Komite Medik 2. Terlaksananya audit medis dengan Pimpinan Medis dan Komite Medik						
15.	Sistem pelaporan dan pembelajaran keselamatan pasien di rumah sakit (SP2KP-RS) meliputi kejadian sentinel, Kejadian yang Tidak Diharapkan (KTD), Kejadian Tidak Cedera (KTC), Kejadian Nyaris Cedera (KNC) dan Kejadian Potensial Cedera (KPC). Mekanisme pelaporan insiden keselamatan pasien baik internal maupun eksternal, grading matriks risiko serta investigasi dan analisa insiden berdasarkan hasil grading. Adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut:	Melaporkan insiden yang terjadi di unit menggunakan form laporan dan billing RS	Laporan langsung / tidak langsung	Instrumen pangambilan data	Januari – desember 2026	UMANDOK	

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
	1. Terlaksananya pelaporan IKP secara internal ke tim KPRS 2. Terlaksananya investigasi dan perbaikan berdasarkan risk matrix grading 3. Terlaksana pelaporan IKP ke representative pemilik 4. Terlaksananya pelaporan IKP secara eksternal ke KNKP						
16.	Pengukuran budaya keselamatan pasien perlu dilakukan oleh RS dengan melakukan survei budaya keselamatan pasien setiap tahun. Adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut: 1. Terlaksananya pengukuran budaya keselamatan 2. Terlaksananya analisa dan tindak lanjut hasil budaya keselamatan	Melakukan survei secara online menggunakan google form dengan sasaran seluruh petugas	Survey	Instrumen pangambilan data	November 2026	UMANDOK	
17.	Komite Mutu membuat daftar resiko tingkat rumah sakit berdasarkan daftar risiko yang dibuat tiap unit setiap tahun.	Melakukan Analisa resiko yang mungkin terjadi di unitnya Bersama dengan kepala ruang dan tim	Observasi dan analisa	Instrumen pangambilan data	Desember 2025	UMANDOK	

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
	Adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut: 1. Melakukan identifikasi risiko ditingkat unit dan tingkat RS 2. Menyusun Risk register 3. Menyusun strategi untuk menurunkan risiko 4. Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap risiko di unit 5. Terlaksananya pelaporan hasil monitoring kepada direktur dan representative pemilik 6. Menyusun FMEA 7. Melakukan monitoring tindak lanjut FMEA	manajemen risiko dan membuat risk register					

3.4. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2026

NO	KEGIATAN	SASARAN	TAHUN 2025	TAHUN 2026												TEMPAT	PIC	SUMBER DANA	KET
			12/ 24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1.	Penambahan Ketua Komite PMKP full time (diutamakan dengan latar pendidikan Dokter Umum)	Dokter Umum		√												RSPHS	SDM RS	PT Disa Prima Medika	

2.	Pelatihan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) dan Manajemen Resiko	1. Ketua PMKP 2. Sekretaris PMKP 3. Ketua Sub Komite Peningkatan Mutu 4. Ketua Sub Keselamatan Pasien 5. Ketua Sub Manajemen Risiko	Tentatif menyesuaikan Jadwal Pelatihan PMKP dan Manajemen Risiko dari KARS	Tergantung Penyelenggaraan	SDM RS	PT Disa Prima Medika	
3.	Pelatihan Penyusunan Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) dan Root Cause Analysis (RCA)	1. Ketua PMKP 2. Sekretaris PMKP 3. Ketua Sub Keselamatan Pasien	Tentatif menyesuaikan Jadwal Pelatihan PMKP dan Manajemen Risiko dari KARS	Tergantung Penyelenggaraan	SDM RS	PT Disa Prima Medika	
4.	Pelatihan Implementasi Kendali Mutu Biaya pada bab PMKP	1. Ketua PMKP 2. Sekretaris PMKP 3. Ketua Sub Komite Peningkatan Mutu	Tentatif menyesuaikan Jadwal Pelatihan PMKP dan Manajemen Risiko dari KARS	Zoom	SDM RS	PT Disa Prima Medika	
5.	Orientasi Umum - Pengenalan Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) di RS Prima Husada Sukorejo	Karyawan Baru	Tentatif menyesuaikan Jadwal Orientasi dari SDM RS Prima Husada Sukorejo	Hall Sakura RSPH Sukorejo	Komite PMKP	-	

6.	<i>Refreshment & Training PMKP</i> Materi: 1. Indikator Mutu Nasional, Indikator Mutu Prioritas RS, Indikator Mutu Unit 2. Macam-macam Insiden Keselamatan Pasien dan Alur Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien dan Budaya Keselamatan 3. Manajemen Resiko	Seluruh Staff di RS Prima Husada Sukorejo							√						√	Hall Sakura RSPH Sukorejo	Komite PMKP	-	
7.	Pelatihan Pengambilan Data Mutu Materi: 1. Refreshment Indikator Mutu yang berlaku di Unit 2. Alur Pengumpulan Data Mutu baik di SIMRS maupun <i>Google Spreadsheet</i> 3. Cara analisa permasalahan sesuai dengan kondisi di unit sampai dengan	PIC Data Mutu Unit		√												Hall Andalusia Lantai 3 RSPH Sukorejo	Komite PMKP	-	

	tindak lanjut perbaikan 4. Praktik mengumpulkan data Mutu baik di SIMRS maupun <i>Google Spreadsheet by name</i> . 5. Praktik mengunduh laporan mutu di SIMRS																		
8.	Pelatihan terkait pengisian CP di Unit Materi: 1. Refreshment Praktik Klinis yang dilakukan Audit 2. Pengisian Form CP di Google Spreadsheet	Karu Rawat Inap, Dokter, Gizi, Farmasi		√												Hall Andalusia Lantai 3 RSPH Sukorejo	Komite PMKP Komite Medik	-	
9.	Regulasi terkait Komite Mutu. Regulasi yang perlu di review yakni:			√															
	a. Penetapan SK Komite Mutu	Direktur RS		√												Sekretariat	Komite PMKP	-	-
	b. Penetapan SK PJ Mutu	Komite PMKP		√															
	c. Penetapan SK PIC Mutu	Komite PMKP		√															
	d. Penetapan SK Validator Mutu	Direktur RS		√															

	e. Penetapan Pedoman Komite Mutu RS	Direktur RS		√															
	f. Penetapan Program Kerja Komite Mutu RS	Direktur RS		√															
	g. Penetapan tentang Sistem Pelaporan dan Pembelajaran Keselamatan Pasien Rumah Sakit (SP2KP RS)	Direktur RS		√															
	h. Penetapan tentang Program Budaya Keselamatan Rumah Sakit	Direktur RS		√															
	i. Penetapan tentang Program Manajemen Risiko Tingkat Rumah Sakit	Direktur RS		√															
10.	Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM). Indikator Nasional Mutu adalah indikator mutu nasional yang wajib dilakukan pengukuran dan digunakan sebagai informasi mutu secara nasional.		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
	a. Terlaksananya pengumpulan dan analisa data	All Unit	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-

	b. Terlaksananya pelaporan indikator mutu Nasional ke Aplikasi SIMAR	Komite PMKP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
	c. Terlaksananya rencana perbaikan & pelaksanaan perbaikan	Komite PMKP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
	d. Terlaksananya monitoring indikator nasional mutu	Komite PMKP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
11.	Pengukuran Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit (IMP-RS):			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
	Direkur beserta Komite Mutu RS. Prima Husada Sukorejo melakukan persiapan berupa pertemuan atau rapat dengan seluruh kepala ruangan, sehingga ada kesamaan pengertian tentang mutu, keselamatan pasien dan manajemen risiko sehingga ditemukan kesepakatan tentang langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan.	Direktur RS & Komite PMKP	√													Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
	Pemilihan Indikator Mutu Prioritas RS (IMP-RS) dan sesuai	Direktur RS & Komite PMKP	√													Hall Andalusia Lantai 3	Komite PMKP	-	-

	dengan TKRS 5 mencakup: a. Indikator Sasaran Keselamatan Pasien (ISKP) b. Indikator Pelayanan Klinis Prioritas c. Indikator sesuai Tujuan Strategis Rumah Sakit (KPI) d. Indikator terkait Perbaikan Sistem e. Indikator terkait Manajemen Risiko																		
	Indikator pelayanan klinis prioritas ditetapkan melalui SK penetapan direktur	Direktur RS	√													Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
	Terlaksananya pengumpulan data, analisa, interpretasi data dan <i>feedback</i> data	Komite PMKP		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
	Terlaksananya pelaporan capaian indikator mutu prioritas RS	Komite PMKP		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
12.	Pengukuran Indikator Mutu Prioritas Unit Indikator Mutu Prioritas Unit (IMP – Unit) adalah indikator prioritas yang khusus dipilih kepala unit		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				

	terdiri dari minimal 1 indikator.																		
	Terlaksananya pemilihan Indikator Mutu Unit	Komite PMKP Kepala Unit	√													Hall Andalusia Lantai 3	Komite PMKP	-	-
	Terlaksananya penetapan Indikator Mutu Unit a. IGD b. Instalasi Rawat Jalan c. Instalasi Rawat Inap 2A d. Instalasi Rawat Inap 2B e. Instalasi Rawat Inap 3A f. Instalasi Rawat Inap 3B g. Instalasi Kamar Operasi h. Maternitas i. Ponek j. Neonatologi k. ICU l. Radiologi m. Laboratorium n. Rehab Medis o. Farmasi p. Gizi q. Rekam Medis r. Limbah-K3RS s. SDM t. Kesekretariatan u. Driver		√													Hall Andalusia Lantai 3	Komite PMKP	-	-

	v. Pemulasaran Jenazah w. ATEM-IPSRs x. Laundry y. CSSD z. Cleaning Service aa. Keamanan bb. Gudang Umum cc. PPI dd. PKRS ee. Verifikator ff. Humas & Marketing gg. MOD-MPP-PIPP hh. TB di IRJA ii. Keuangan jj. HIV kk. KB ll. Stunting mm. IT-SIMRS																		
	Terlaksananya pengumpulan dan analisa data	Komite PMKP Kepala Unit		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
13	Analisa, Pelaporan dan <i>feedback</i> data indikator mutu terintergrasi		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
	a. Terlaksananya pengumpulan data indikatotor mutu oleh PIC disetiap unit kerja sesuai dengan profil indikator	Komite PMKP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-

	b. Terlaksananya analisa data pencapaian indikator sesuai dengan ketentuan analisa data	Komite PMKP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
	c. Terlaksananya validasi data sesuai dengan ketentuan	Komite PMKP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
	d. Terlaksananya pelaporan data indikator mutu dari tingkat unit sampai dengan ke pemilik	PIC Data Mutu Kepala Unit Komite PMKP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
	e. Terlaksananya penyampaian <i>feedback</i> hasil capaian indikator mutu ke semua staf di unit kerja	Komite PMKP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
	f. Terlaksananya publikasi data indikator mutu	Komite PMKP		√			√			√			√			Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
	g. Terlaksananya <i>benchmark</i> data	Komite PMKP		√			√			√			√			Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
	14. Penerapan Standar Pelayanan Kedokteran di Rumah Sakit.		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
	a. Terlaksananya evaluasi CP dengan Komite Medik	Komite Medik Komite PMKP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
	b. Terlaksananya audit medis	Komite Medik Komite PMKP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-

	dengan Pimpinan Medis dan Komite Medik																		
15.	Sistem pelaporan dan pembelajaran keselamatan pasien di rumah sakit (SP2KP-RS) meliputi kejadian sentinel, Kejadian yang Tidak Diharapkan (KTD), Kejadian Tidak Cedera (KTC), Kejadian Nyaris Cedera (KNC) dan Kejadian Potensial Cedera (KPC). Mekanisme pelaporan insiden keselamatan pasien baik internal maupun eksternal, grading matriks risiko serta investigasi dan analisa insiden berdasarkan hasil grading.		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
a.	Terlaksananya pelaporan IKP secara internal ke tim KPRS	Komite PMKP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
b.	Terlaksananya investigasi dan perbaikan berdasarkan risk matrix grading	Komite PMKP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-

	c. Terlaksananya pelaporan IKP ke representative pemilik	Komite PMKP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
	d. Terlaksananya pelaporan IKP secara eksternal ke KNKP	Komite PMKP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
16.	Pengukuran budaya keselamatan pasien perlu dilakukan oleh RS dengan melakukan survei budaya keselamatan pasien setiap tahun.													√					
	a. Terlaksananya pengukuran budaya keselamatan	All Karyawan RSPH Sukorejo												√		Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
	b. Terlaksananya analisa dan tindak lanjut hasil budaya keselamatan	Komite PMKP												√	√	Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
17.	Komite Mutu membuat daftar resiko tingkat rumah sakit berdasarkan daftar risiko yang dibuat tiap unit setiap tahun.		√																
	a. Melakukan identifikasi risiko ditingkat unit dan tingkat RS	All Unit	√													Hall Andalusia Lantai 3	Komite PMKP Komite PPI Komite K3RS	-	-

	b. Menyusun Risk register	Komite PMKP	√													Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
	c. Menyusun strategi untuk menurunkan risiko	Komite PMKP	√													Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
	d. Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap risiko di unit	Komite PMKP	√													Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
	e. Terlaksananya pelaporan hasil monitoring kepada direktur dan representative pemilik	Komite PMKP	√													Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
	f. Menyusun FMEA	Komite PMKP	√													Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
	g. Melakukan monitoring tindak lanjut FMEA	Komite PMKP	√													Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-

3.5. Kebutuhan Anggaran

Semua anggaran akan dibiayai dari anggaran RS Prima Husada Sukorejo yang telah disetujui oleh PT. Disa Prima Medika dengan rincian sebagaimana terlampir:

Tabel 3.5. Kebutuhan biaya pengembangan SDM Komite PMKP tahun 2026

No	Kegiatan/Rincian Kegiatan	Internal Eksternal	Jumlah (Satuan)	Harga Satuan	Total
1	Pelatihan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) dan Manajemen Resiko	Eksternal	5	Rp 5.000.000	Rp 25.000.000
2	Pelatihan Penyusunan Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) dan Root Cause Analysis (RCA)	Eksternal	3	Rp 3.500.000	Rp 10.500.000
3	Pelatihan Implementasi Kendali Mutu Biaya pada bab PMKP	Eksternal	3	Rp 2.000.000	Rp 6.000.000
4	Orientasi Umum - Pengenalan Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) di RS Prima Husada Sukorejo	Internal	3	Rp 100.000	Rp 300.000
5	<i>Refreshment & Training</i> PMKP Materi: a. Indikator Mutu Nasional, Indikator Mutu Prioritas RS, Indikator Mutu Unit b. Macam-macam Insiden Keselamatan Pasien dan Alur Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien dan Budaya Keselamatan c. Manajemen Resiko	Internal	2	Rp 150.000	Rp 300.000
6	Pelatihan Pengambilan Data Mutu Materi: a. Refreshment Indikator Mutu yang berlaku di Unit b. Alur Pengumpulan Data Mutu baik	Internal	1	Rp 100.000	Rp 100.000

No	Kegiatan/Rincian Kegiatan	Internal Eksternal	Jumlah (Satuan)	Harga Satuan	Total
	di SIMRS maupun <i>Google Spreadsheet</i> c. Cara analisa permasalahan sesuai dengan kondisi di unit sampai dengan tindak lanjut perbaikan d. Praktik mengumpulkan data Mutu baik di SIMRS maupun <i>Google Spreadsheet by name</i> . e. Praktik mengunduh laporan mutu di SIMRS				
7	Pelatihan terkait pengisian CP di Unit Materi: a. Refreshment Praktik Klinis yang dilakukan Audit b. Pengisian Form CP di <i>Google Spreadsheet</i>	Internal	1	Rp 100.000	Rp 100.000
8	Honorarium narasumber pelatihan insidentil (DPJP) 4 kali pelatihan x 4 org DPJP	Eksternal	20	Rp 250.000	Rp 5.000.000
9	Penggunaan Platform Quizizz untuk Pelatihan Pre-Test dan Post-Test	Internal	12	Rp 1.254.000	Rp 15.048.000
TOTAL					Rp 62.348.000

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

3.1. Monitoring

Sesuai dengan Permenkes No. 80 Tahun 2020 tentang Komite Mutu Rumah Sakit, kegiatan monitoring Komite PMKP dilakukan dalam bentuk:

1. Monitoring, supervisi dan memandu penerapan program mutu di unit kerja
2. Monitoring, supervisi dan memandu unit kerja dalam memilih prioritas perbaikan, pengukuran mutu/indikator mutu, dan menindaklanjuti hasil capaian indikator mutu
3. Monitoring, supervisi dan memandu penerapan keselamatan pasien di unit kerja
4. Monitoring, supervisi dan memandu penerapan manajemen risiko di unit kerja

3.2. Evaluasi

Sesuai dengan Permenkes No. 80 Tahun 2020 tentang Komite Mutu Rumah Sakit, kegiatan evaluasi Komite PMKP dilakukan dalam bentuk:

1. Rapat rutin dengan PIC Data Unit terkait capaian indikator mutu unit setiap bulan
2. Rapat Triwulanan dengan Kepala Ruang dan Jajaran Manajemen terkait capaian indikator mutu, insiden keselamatan pasien yang ada di unit
3. Pemberian masukan dan pertimbangan kepada Direktur Rumah Sakit terkait perbaikan mutu tingkat Rumah Sakit
4. Rapat pemilihan prioritas perbaikan tingkat Rumah Sakit dan pengukuran indikator tingkat Rumah Sakit serta menindaklanjuti hasil capaian indikator
5. Rapat pemilihan risk register unit dengan Kepala Ruang, Seluruh Komite dan jajaran Manajemen untuk dilakukan profil register.
6. Motivasi, edukasi, konsultasi, pemantauan dan penilaian tentang penerapan program keselamatan pasien
7. Melakukan Root Cause Analysis (RCA) dan pemberian solusi untuk meningkatkan keselamatan pasien
8. Evaluasi dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali oleh bidang bagian dan dianalisa setiap triwulan, untuk di berikan rekomendasi dan di sampaikan kepada Pemilik (Direktur PT)
9. Setelah ada feedback maka disampaikan melalui direktur ke Komite Mutu, Komite Mutu menyampaikan feedback kepada manajer untuk ditindak lanjuti

BAB V

PENCATATAN DAN PELAPORAN

1. Kegiatan pengumpulan data indikator mutu di lakukan oleh PIC data unit dengan menggunakan worksheet yang ada di google yang ada di google drive
2. Data yang dikumpulkan diverifikasi oleh kepala instalasi dan dilihat apakah sudah sesuai dengan profil indikator atau belum.
3. Setiap capaian indikator di rekapitulasi setiap bulan, dilengkapi dengan analisa dan tindak lanjut.
4. Setiap tiga bulan, data tersebut direkap dan dianalisis oleh manajer menjadi laporan triwulan sebagai bentuk evaluasi unit.
5. Komite Mutu bertugas melakukan validasi data hasil kegiatan jika hasil kegiatan jika ada data yang harus dievaluasi sesuai kebutuhan dalam prosedur validasi.
6. Setelah data valid maka laporan dari hasil analisa analisa setiap unit direkap menjadi laporan hasil kegiatan rumah sakit, Direktur RS melaporkan kepada Direktur PT Pemilik RS
7. Setelah ada Feedback dari Direktur PT Pemilik RS kepada Direktur RS maka disosialisasikan kepada semua manajer untuk penyusunan tindak lanjut dan diinformasikan kepada semua staf diunit kerja.
8. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh dari setiap kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan, hasil evaluasi disampaikan oleh Komite Mutu dan diserahkan ke Direktur PT Pemilik RS untuk ditindaklanjuti.

BAB VI PENUTUP

Demikian program kerja Komite Mutu disusun dan disampaikan sebagai acuan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di RS Prima Husada Sukorejo tahun 2026. Segala dukungan dan kerjasama yang diberikan dapat menunjang terlaksananya program kerja yang sudah disusun.

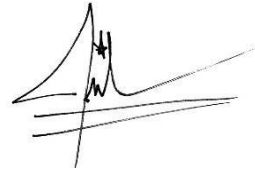
Pasuruan, 19 November 2025

Mengetahui
Manajer Mutu & Pelayanan PT Disa Prima
Medika

Komite PMKP



**Dr. dr. Aslichah, M.Kes.,
AFP.,CHT.,CHMed.Cl.,IACT., CHAE**



Lidia Puspita Kencana, S.K.M.

Menyetujui,
Direktur RS Prima Husada Sukorejo



Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep. M.Kep.